

Неонатальный холестаз

Прямой билирубин выше 17 · не пропустить билиарную атрезию · УДХК и витамины

1. ПОРОГ ТРЕВОГИ — ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН

Главная цифра
Прямой билирубин **выше 17 мкмоль/л** у ребёнка до двух недель жизни — показание к обследованию на билиарную атрезию и другие холестатические болезни печени, **независимо от уровня общего билирубина**.

Возраст	Когда обследовать
До 2 недель жизни	Прямой билирубин > 17 мкмоль/л при любом общем
Старше 2 недель	Прямой > 17 мкмоль/л при общем менее 85 мкмоль/л или прямой более 20% от общего при общем выше 85
Синдром холестаза установлен	Прямой выше 20% от общего или более 17 мкмоль/л в первые 7 суток плюс повышение ЩФ, ГГТ, холестерина и желчных кислот

Затянувшаяся желтуха у ребёнка второй недели жизни — это не «просто желтуха грудного молока», пока не измерена **прямая фракция**.

2. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ: ТРИ КАРТИНЫ ПО ЛАБОРАТОРИИ

	Транзиторный холестаз	Билиарная атрезия	Неонатальный гепатит
Маркёры холестаза	Повышены	Нарастают от минимальных в первые 2-3 недели до значительных к 2-3 месяцам	Повышены
АЛТ и АСТ	Отсрочено, менее чем в 6-8 раз	Умеренно и отсрочено, первые 2-3 недели часто в норме	Более чем в 8-10 раз
АЛТ / АСТ	Менее 1	—	Больше 1
Синтетическая функция печени	Не изменена	Не изменена в первые 3-4 месяца	Снижены альбумин, холинэстераза, фибриноген, ПТИ

Диссоциация **низкий ГГТ при высоком прямом билирубине и ЩФ** характерна для прогрессирующего семейного внутрипечёночного холестаза и врождённых нарушений синтеза жёлчных кислот — повод для генетика.

3. БИЛИАРНАЯ АТРЕЗИЯ — ЧТО НЕ ДАЁТ ЕЁ ПРОПУСТИТЬ

Признак	Как выглядит
Ребёнок	Чаще доношенный, с нормальными антропометрическими показателями
Желтуха	Появляется на 2-3-и сутки — в обычные для физиологической сроки
«Светлый промежуток»	У двух третей: к концу 1-2-й недели желтуха слабеет, потом нарастает снова, к концу месяца — зеленоватый оттенок
Стул	Ахолия — самый ранний и постоянный признак. Часто ей предшествует отхождение мекония
Печень	При рождении не увеличена, затем растёт и уплотняется за первые два месяца
К месяцу жизни	Геморрагический синдром: кровоточивость слизистых ЖКТ, пупочной ранки, внутричерепное кровоизлияние
К 1-2 месяцам	Дефицит веса, тем больше, чем обычнее питание

Ловушка с цветом стула
На лечебных смесях с добавлением среднепечочных триглицеридов эквивалентом обесцвеченного стула бывают **разные оттенки серого**. Не ждите белого — сравнивайте с тем, что было раньше у этого же ребёнка.

4. ОБЪЁМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Что	Зачем
Биохимия: билирубин общий и фракции, ЩФ, ГГТ, холестерин, АЛТ, АСТ, альбумин, глюкоза, мочеви́на, креатинин, КФК	Подтвердить холестаз и отделить цитолиз; почки — при подозрении на синдром Алажилля
Желчные кислоты крови	Маркёр холестаза
Коагулограмма: ПТИ, фибриноген, ПВ, АЧТВ, тромбиновое время	Дефицит витамина К — риск кровотечения
Клинический анализ крови	Инфекция, анемия, тромбоцитопения
ПЦР крови на инфекции	Инфекционная природа гепатита
УЗИ органов брюшной полости и почек	Желчный пузырь, протоки, киста общего жёлчного протока, аномалии почек
Эхокардиография	Пороки сердца при синдроме Алажилля
Рентгенография грудного отдела позвоночника	Позвонки-бабочки при синдроме Алажилля
Офтальмолог	Задний эмбриотоксон — у 78-89% пациентов с синдромом Алажилля
Детский хирург	При подозрении на билиарную атрезию — вопрос о портоэнтеростомии по Касаи
Генетик	Холестаз неясной этиологии — объём молекулярно-генетической диагностики

5. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Основа	Специализированная смесь с повышенным содержанием среднецепочечных триглицеридов: они всасываются без участия жёлчных кислот	Доля СЦТ	30-50% от общих липидов
Чего избегать	Более 80% СЦТ без добавления полиненасыщенных жирных кислот — иначе ятрогенный дефицит незаменимых жирных кислот	Что учитывать при выборе	Выраженность и длительность холестаза, гестационный и постнатальный возраст, нарушение всасывания других компонентов

6. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Препарат	Доза	Замечания
Урсодезоксихолевая кислота	20-30 мг/кг/сут в два приёма перорально, длительно	Всем новорождённым с синдромом холестаза
Колекальциферол	1000-2500 МЕ/сут, не менее месяца	Доза корректируется по уровню 1,25-ОН витамина D
Ретинол	3000-10 000 МЕ/сут перорально	
Витамин Е	50 мг/сут при массе > 1 кг; 25 мг/сут при массе < 1 кг	Вместе с витамином D улучшает его всасывание
Витамин К (фитоменадион)	1 мг/кг раз в неделю при массе < 5 кг; 2,5-5 мг 1-3 раза в неделю или 10 мг раз в 2 недели при массе > 5 кг	При холестазе — парентерально. Доза по коагулограмме, в тяжёлых случаях ежедневно

Жирорастворимые витамины назначаются при длительности холестаза **более 10 дней**. Дефицит витамина Е даёт неврологию — нейропатию и атаксию, дефицит витамина А — поражение роговицы вплоть до слепоты.

7. ЧТО В РУКАХ НЕОНАТОЛОГА

- Лечить основное заболевание: холестаз у новорождённого чаще всего — осложнение тяжёлой внепечёночной патологии, а не болезнь печени.
- **Исключить или ограничить гепатотоксичные препараты** и препараты крови.
- **Раннее начало энтерального питания**: полное парентеральное питание — самостоятельный фактор риска холестаза.
- Желчегонная терапия с учётом незрелости экскреторных механизмов у новорождённого.
- Следить за прибавкой массы: мальабсорбция жиров быстро даёт дефицит веса.

8. ХИРУРГИЯ

Ситуация	Что делают
Билиарная атрезия	Портоэнтеростомия по Касаи — минилапаротомия или лапароскопия
Киста общего жёлчного протока	Полное иссечение с билиодигестивным анастомозом по Ру
Трансплантация печени	В неонатальном периоде не проводится
Остальные формы холестаза	Хирургическое лечение в неонатальном периоде не показано

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Неонатальный холестаз» — ID 959_1, размещены 31.10.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/959_1

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Геморрагическая болезнь плода и новорожденного» — ID 906_1, размещены 15.04.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/906_1

— Пороги прямого билирубина, лабораторные портреты и дозы приведены по разделам 2 и 3 КР «Неонатальный холестаз»; дозы витамина К совпадают с КР «Геморрагическая болезнь плода и новорождённого».